

Programme d'optimisation périopératoire du patient adulte

Champ 1-2 — Généralités & mesures préopératoires



Résumé : socle commun de recommandations applicables quelle que soit la chirurgie (à la différence des RFE de réhabilitation améliorée déjà git-trackées dans ce corpus, spécifiques à une chirurgie) — une mesure devait être valable dans au moins 3 domaines chirurgicaux distincts pour être retenue ici. 30 recommandations (accord fort, décompte source vérifié exact) et 2 absences de recommandation, sur 4 champs : généralités, mesures préopératoires, peropératoires, postopératoires.

GRADE — 1+/1- : recommandation **forte** (« il faut faire / ne pas faire », ≥ 70 % d'opinion convergente) ; 2+/2- : recommandation **faible** (« il est probablement recommandé de faire / ne pas faire », preuve modérée/faible) ; **AE** : avis d'experts (preuve très faible ou littérature quasi inexistante). Règle de scope : une mesure devait être valable dans au moins 3 domaines chirurgicaux pour faire l'objet d'une recommandation ici.

1+

1-

2+

2-

AE

Champ 1 — Généralités sur le programme d'optimisation périopératoire

Réf.	Recommandation	Grade
R1.1	Mettre en place et appliquer un programme d'optimisation périopératoire, pour réduire la durée de séjour et l'incidence des complications postopératoires.	1+

Absence de recommandation (données insuffisantes) : place de la médecine de ville dans les périodes pré- et postopératoire d'un programme d'optimisation périopératoire.

Réf.	Recommandation	Grade
R1.2	Les experts suggèrent que l'implémentation et le suivi des programmes d'optimisation périopératoire soient effectués par une équipe pluriprofessionnelle, avec du temps dédié pour la coordination du parcours patient.	AE
R1.3	Inclure tous les patients dans un programme d'optimisation périopératoire, notamment les patients âgés, fragiles ou comorbides, chez qui ce type de prise en charge diminue aussi le taux de complications postopératoires et la durée de séjour.	1+

Champ 2 — Mesures préopératoires

Réf.	Recommandation	Grade
R2.1	Mettre en œuvre un programme de préhabilitation avant chirurgie, pour réduire la morbidité et la durée de séjour postopératoire.	2+
R2.2	Limiter la durée du jeûne préopératoire à 6 heures pour les solides et encourager la prise de liquides clairs (eau, thé, café, sucrés ou non, jus de fruit sans pulpe) jusqu'à 2 heures avant la chirurgie, pour réduire l'anxiété préopératoire et la durée de séjour.	1+
R2.3	Ne pas prescrire systématiquement de prémédication sédatrice avant une intervention, pour réduire la survenue de complications postopératoires.	1-
R2.4	Admettre les patients le jour de l'intervention, pour réduire la durée de séjour sans modifier la survenue de complications.	2+
R2.5	Mettre en place un programme de gestion personnalisée du capital sanguin (« patient blood management »), pour réduire la durée de séjour et les complications postopératoires.	2+

Programme d'optimisation périopératoire du patient adulte

Champ 3 — Mesures peropératoires



Champ 3 — Mesures peropératoires (1/2)

Réf.	Recommandation	Grade
R3.1	Ne pas privilégier une modalité d'anesthésie générale (intraveineuse vs inhalée ; avec vs sans opiacés), pour réduire la durée d'hospitalisation et les complications postopératoires.	1-
R3.2	Ne pas privilégier un type d'anesthésie (loco-régionale neuraxiale vs générale) en chirurgie des membres inférieurs, pour réduire la durée d'hospitalisation et les complications postopératoires.	1-
R3.3	Mettre en place une ventilation protectrice — volume courant 6-8 ml/kg de poids idéal théorique, PEP ≥ 5 cmH ₂ O, manœuvres de recrutement alvéolaire itératives — en chirurgie programmée de l'adulte, pour diminuer les complications postopératoires.	1+
R3.4	Administrer des anesthésiques locaux par voie péri-nerveuse en chirurgie des membres, pour réduire les complications postopératoires.	1+
R3.5	Réaliser une analgésie loco-régionale après une chirurgie thoracique ou abdominale majeure (dont vasculaire) par voie ouverte, pour réduire les complications postopératoires.	1+
R3.6	Réaliser une analgésie loco-régionale pour une chirurgie thoracique par vidéothoroscopie, une chirurgie pariétale thoraco-abdomino-pelvienne ou une chirurgie rachidienne, pour réduire l'incidence des complications postopératoires.	2+
R3.7	Utiliser la lidocaïne IV en peropératoire de chirurgie abdomino-pelvienne laparoscopique, pour réduire l'incidence des complications postopératoires.	2+
R3.8	Optimiser les apports liquidiens peropératoires en se basant sur la pression artérielle et le volume d'éjection systolique, pour diminuer les complications postopératoires et la durée d'hospitalisation.	2+

Champ 3 — Mesures peropératoires (2/2)

Réf.	Recommandation	Grade
R3.9	Utiliser un monitoring de la profondeur d'anesthésie, notamment chez les patients à risque (chirurgie ou comorbidités), pour diminuer les complications neuro-cognitives postopératoires.	2+

Absence de recommandation (données insuffisantes) : monitoring de l'analgésie (moniteurs d'analgésie) dans le cadre de la réhabilitation accélérée postopératoire — sous-question de R3.9, littérature actuelle insuffisante.

Réf.	Recommandation	Grade
R3.10	Lutter contre l'hypothermie péri-opératoire, pour diminuer la survenue de complications postopératoires.	1+
R3.11	Mettre en place un protocole de prévention des nausées et vomissements postopératoires, pour favoriser la réhabilitation postopératoire.	1+
R3.12	Administrer de la dexaméthasone IV (4 ou 8 mg) lors de chaque anesthésie générale, pour réduire les complications postopératoires, en particulier les NVPO.	1+
R3.13	Administrer de l'acide tranexamique en peropératoire de chirurgie majeure et/ou à risque hémorragique, pour réduire les complications hémorragiques et le recours à la transfusion péri-opératoire.	1+
R3.14	Administrer une antibioprophylaxie en respectant les indications et modalités de la RFE SFAR « Antibioprophylaxie » (déjà git-trackée dans ce corpus), pour réduire les infections du site opératoire.	1+
R3.15	Monitorer la curarisation et respecter la RFE SFAR « Curarisation et décurarisation en anesthésie » pour la décurarisation, pour réduire les complications postopératoires.	1+



Champ 4 — Mesures postopératoires

Réf.	Recommandation	Grade
R4.1	Utiliser une analgésie multimodale associant antalgiques non morphiniques et anesthésiques locaux, pour réaliser une épargne morphinique et réduire la durée de séjour et les complications postopératoires.	1+
R4.2	Implémenter des protocoles de thromboprophylaxie (déambulation précoce, thromboprophylaxie médicamenteuse, compression pneumatique intermittente selon le risque thromboembolique lié à la chirurgie et au patient), pour réduire les événements thromboemboliques veineux et les complications postopératoires.	1+
R4.3	Mettre en place les mesures du programme d'optimisation dès la SSPI (reprise des boissons, déambulation, retrait des cathéters et de la sonde urinaire), pour diminuer la durée de séjour et les complications postopératoires.	2+
R4.4	Débuter une alimentation orale dans les 24 premières heures postopératoires, y compris après chirurgie avec anastomoses digestives (hors chirurgie carcinologique de l'oropharynx et en l'absence de contre-indication chirurgicale), pour limiter la durée de séjour et les complications.	1+
R4.5.1	Faire déambuler le patient idéalement dans les 12 premières heures et dans tous les cas avant la 24 ^e heure postopératoire, pour réduire la durée de séjour.	1+
R4.5.2	Faire déambuler le patient idéalement dans les 12 premières heures et dans tous les cas avant la 24 ^e heure postopératoire, pour réduire les complications postopératoires.	2+
R4.6	Établir une liste de critères de sortie d'hospitalisation, pour réduire la durée de séjour sans impacter la survenue de complications postopératoires.	2+

Sources et avertissement

Méthode : groupe de 29 experts SFAR, méthode GRADE (analyse bibliographique sur 10 ans, PRISMA, format PICO), vote GRADE grid en 2 tours. Règle de scope propre à ce document : une mesure devait être valable dans au moins 3 domaines chirurgicaux distincts pour faire l'objet d'une recommandation — les argumentaires ne discutent donc pas systématiquement tous les domaines et certaines recommandations peuvent ne pas s'appliquer à des chirurgies particulières.

Document source : SFAR, « Programme d'optimisation périopératoire du patient adulte », RFE, texte validé par le Comité des Référentiels Cliniques le 13/06/2022 et le Conseil d'Administration le 29/06/2022.

URL source : <https://sfar.org/programme-doptimisation-perioperatoire-du-patient-adulte/>

Couverture : intégralité des 30 recommandations et des 2 absences de recommandation (4 champs, 26 questions). L'Annexe 1 (2 forest-plots méta-analytiques soutenant R3.1, TIVA vs inhalation sur la survie/récidive carcinologique) et le schéma synoptique du programme mentionné dans la synthèse ne sont pas retranscrits — purement évidentiaires/illustratifs, sans information clinique au-delà du texte des recommandations. Composition nominative des groupes de travail et bibliographie complète non reproduites.

Avvertissement : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les 30 recommandations et les 2 absences de recommandation du texte source, mais condense l'argumentaire de chaque item. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la SFAR.